

INTOXICACIÓN POR DROGAS

Marta Sainz de Andueza, Cristina Güemes de la Iglesia, María del Carmen Hernández Tuda.

Las drogas con mayor prevalencia de consumo en nuestro país son el alcohol (77,6%), tabaco (40,2%), hipnosedantes (12,0%), cannabis (9,5%) y cocaína (2,0%). El consumo de cannabis en el colectivo de 15 a 34 años asciende a 17,1%.

El inicio más precoz en el consumo es para el tabaco y alcohol, 17 años, seguido del cannabis, 18 años. La prevalencia de consumo de alcohol continua en niveles altos desde la década de los noventa, el cannabis tiene tendencia claramente ascendente, la heroína está estabilizada desde mediados de los años noventa, y la cocaína, anfetaminas éxtasis y alucinógenos tienen tendencia descendente en la última década.

El policonsumo se concentra en hombres de 25 a 34 años, incluye hasta en el 90% de casos alcohol y cannabis, y se asocia a otros consumos de riesgo. En 2015, el 43,4% de las urgencias relacionadas con el consumo no médico de sustancias psicoactivas se relacionó con cocaína, 42,2% con cannabis, 11,2% con heroína y 8,0% con anfetaminas.

Las nuevas sustancias psicoactivas son aquéllas que imitan el efecto de drogas ilegales, presentadas en forma de hierba, pastillas, polvo, líquido, incienso u otras, incluidas en un perfil, en la mayoría de casos, de policonsumo experimental. Actualmente, se trata de un fenómeno minoritario en España, aunque se lleva a cabo vigilancia activa a través del Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT). En 2016, ha notificado 43 nuevas sustancias psicoactivas.

ETANOL

Se trata de un hidrocarburo volátil con rápida absorción en estómago e intestino delgado, cuyo consumo regular produce un marcado fenómeno de tolerancia variando mucho las manifestaciones clínicas según sea un consumidor esporádico o crónico.

Diagnóstico: la agitación y el coma son los motivos más frecuentes de consulta en Urgencias. Las manifestaciones clínicas son predecibles a partir de la tasa de etanol en sangre:

- > 1 g/L Desinhibición, agitación, trastornos de conducta, labilidad emocional, ataxia, disartria, mareo, náuseas, vómitos.
- 2-4 g/L Malestar general, discurso incoherente, bradipsiquia, incoordinación motora, somnolencia, estupor, obnubilación y en ocasiones agitación intensa. En casos extremos, con > 3 g puede desencadenar un coma.
- > 4 g/L Coma profundo y > 5 g/L Riesgo de parada respiratoria

Son característicos el fetor enólico, la vasodilatación conjuntival, y en intoxicación severa, el nistagmus. Otros hallazgos son los vómitos reiterados, que podrían desencadenar un síndrome de Mallory-Weiss, la acidosis metabólica, crisis comiciales, arritmia cardíaca y datos de pancreatitis asociada o hepatitis aguda alcohólica.

- Es necesario siempre descartar hipoglucemia, realizar ECG y una exploración neurológica descartando organicidad.
- Se puede determinar el etanol en sangre a partir del análisis de suero, saliva o aire espirado.

Tratamiento: No hay antídoto. Protección de vía aérea, ventilación mecánica y oxigenoterapia en intoxicación grave.

El vaciado gástrico no procede y el carbón activado es ineficaz a menos que coexista ingesta de otros tóxicos.

En caso de agitación, el fármaco de elección son Benzodiacepinas, y si predomina la psicosis, Haloperidol. Evitar otros neurolépticos por riesgo de rigidez, hipertermia y convulsiones.

Debe valorarse el uso de Tiamina 100 mg IM para prevenir encefalopatía de Wernicke en caso de enolismo crónico.

Aunque la recuperación espontánea y sin secuelas en pocas horas es lo habitual, las complicaciones más frecuentes son las traumáticas y la broncoaspiración.

CANNABIS

Droga de abuso obtenida de la planta Cannabis sativa, con el Δ^9 -tetrahidrocannabinol (9-THC) como principio activo, con efectos dosis dependientes y distintos preparados con diferente grado de pureza. El porro, mezcla de tabaco y Cannabis sativa en un cigarrillo, es la forma más habitual de consumo en España, ya sea en forma de hojas desecadas (marihuana) o de resina (hachís). El consumo de cannabis por vía oral se realiza con preparados de repostería.

Diagnóstico: Las dosis bajas producen euforia y bienestar, pero en ocasiones genera ansiedad, trastornos de la percepción, dolor torácico, psicosis y reacciones de pánico.

Las dosis altas producen agitación al inicio y posteriormente depresión, sensación de mareo, incoordinación motora, vasodilatación conjuntival y en ocasiones vómitos. Algunos pacientes pueden llegar a tener alucinaciones y los efectos pueden potenciarse por el consumo asociado de alcohol. Se han descrito ictus isquémicos en consumo moderado.

El 9-THC se identifica en orina. Será positivo hasta un mes después, no patognomónico de intoxicación aguda.

Tratamiento: el cannabis no tiene antídoto. Sedación con Benzodiacepinas si precisa, y resuelta la sintomatología aguda, alta hospitalaria. No hay riesgo vital.

COCAÍNA

Alcaloide natural extraído de la planta Erythroxylum coca, siendo sus diversos derivados muy tóxicos y adictivos: clorhidrato de cocaína es el preparado más distribuido, consumido por vía nasal o iv., su transformación en base pura sólida, el crack o cocaína base, se calienta y consume inhalado, y la mezcla de cocaína y heroína, el "Speed-Ball".

Produce estimulación del SNC, y en caso de sobredosis, > 20 mg esnifada o iv. y > 1gr oral, es potencialmente mortal. En este último caso es necesario incluir a los "Body-packers" y "Body-stuffers" ya mencionados en este capítulo.

Diagnóstico: el inicio del cuadro clínico suele ser precoz, en minutos tras el consumo.

Clínica neurológica: midriasis característica, ansiedad, euforia, temblor, agitación, psicosis y delirio. En ocasiones cefalea, mareo, inestabilidad, mioclonías y movimientos coreoatetósicos hasta convulsiones y coma. Además, puede desencadenar un ictus isquémico por vasoespasmo y efecto protrombótico, o por el contrario, HSA secundaria a HTA.

Clínica cardiovascular: lo más frecuente son palpitaciones, constatándose taquicardia sinusal e

HTA. Disnea, dolor torácico con cardioapatía isquémica por vasoespasma coronario, otras taquiarritmias y EAP. Hipotensión arterial y shock son signos de extrema gravedad poco frecuentes, y también se han descrito aneurisma y ruptura aórtica.

En ECG otros hallazgos son bradicardia con síndrome de QT largo y “Torsade de pointes”.

Otros síntomas: sudoración, hipertermia, náuseas, vómitos, sequedad bucal, isquemia intestinal, mialgias, rabdomiólisis, insuficiencia renal, alteraciones del equilibrio ácido-base y trastornos funcional hepático y pancreático. Están descritos muerte súbita, hipertermia maligna, CID y shock refractario tras sobredosis por vía parenteral.

El consumo crónico esnifada produce epistaxis, rinitis crónica, sinusitis, y perforación del tabique nasal, y fumada, quemaduras en pulpejo de dedos.

Pruebas complementarias: hemograma, función renal e iones (hiponatremia), CPK, marcadores cardíacos, coagulación, gasometría arterial, mioglobina y tóxicos en orina, ECG, Rx (transporte ilegal), y TAC si indicación.

Tratamiento: no hay antídoto. Tratamiento sintomático con monitorización cardiorrespiratoria y medidas de soporte vital si fuera necesario. Descontaminación digestiva, carbón activado y valorar Polietilenglicol en “Body-packers”.

Sedación: Benzodiacepinas iv. IM, vo. o sl., contención física si precisa y psicoterapia. Evitar Neurolépticos.

Arritmia supraventricular: sedación con Benzodiacepinas frenando la descarga simpaticomimética. Si es necesario, Verapamilo 5-10mg, iv., Diltiazem 20mg iv. o Adenosina 6-12mg iv. Cardioversión eléctrica si precisa.

Arritmia ventricular: sedación con Benzodiacepinas de nuevo, seguido de Bicarbonato sódico 50-100 mEq iv por riesgo de acidosis metabólica e hipopotasemia. Si es necesario, Lidocaína en bolus de 1-1,5 mg/Kg seguido de perfusión de 2-4 mg/Kg/min o Amiodarona si han pasado más de 60' del consumo. Cardioversión eléctrica si precisa.

Bradicardia con QT largo +/- Torsade de pointes: Isoproterenol 5 amp de 1mg en 250ml SG 5% a 15 ml/h, Sulfato Magnésico 1,5 g iv. y si QRS ancho de base, Bicarbonato sódico 50-100 mEq iv. Si no hay respuesta Marcapasos.

HTA: Benzodiacepinas. Si mal control, Nitroglicerina 3 amp de 5mg en 250ml SG 5% a 21 ml/h, Fentolamina 5-10mg iv. /5-15' o Nitroprusiato 1 amp de 50mg en 250ml SG 5% a 21-63 ml/h. Los Betabloqueantes están contraindicados.

Hipotensión arterial: posición de Trendelenburg, sueroterapia y expansores iv. Si no hay respuesta, Noradrenalina 1amp de 10mg en 250 ml SG 5% a 6-54 ml/hora.

Convulsiones: Diazepam 10 mg iv. Midazolam 0,1 mg/ Kg iv. o Clonazepam 1-2 mg iv como segunda opción. Si movimientos coreoatetósicos, Biperideno 5 mg iv lento.

Hipertermia: medidas físicas y Benzodiacepinas, los antipiréticos son ineficaces. Si hipertermia >40°C, considerar una posible “hipertermia maligna” con rabdomiolisis y CID como posibles complicaciones, e iniciar tratamiento específico.

La cocaína puede estar asociada en policonsumo o estar adulterada, por lo que el cuadro clínico varía y su tratamiento debe realizarse en función de los signos y síntomas predominantes. Un

consumo crónico genera tolerancia.

Debe mantenerse al paciente en Observación un mínimo de 6 horas antes de dar el alta.

HEROÍNA

Derivado semisintético extraído de la amapola del opio, cuyo principio activo es Diacetil-morfina. Consumida durante años exclusivamente intravenosa, en las últimas décadas se han incrementado la vía nasal y pulmonar ("chinos").

Diagnóstico: Clínico, CPK, gasometría arterial, tóxicos en orina, Rx tórax.

Triada clínica clásica en el 95% de casos: coma + depresión respiratoria + miosis puntiforme. Variable cuando se han asociado otros tóxicos o cuando la anoxia provoca, por ejemplo, midriasis. Buscar signos de venopunción.

Otros hallazgos son broncoaspiración, rabdomiólisis, fracaso renal agudo, convulsiones, hipotensión o shock, bradicardia, náuseas y vómitos, retención urinaria, íleo, hipoglucemia, hipotermia y EAP no cardiogénico.

Rx abdomen si sospecha de transporte de drogas de abuso: Body packer y Body stuffer.

Tratamiento. El antídoto es Naloxona, administrable iv. IM, sc. o endotraqueal para revertir la depresión del nivel de conciencia, garantizar la vía aérea permeable, una adecuada ventilación alveolar y un eficaz reflejo tusígeno:

- 0,4 mg en coma superficial, 0,8 mg en coma profundo o depresión respiratoria y 1,2 mg en apnea o PCR.
- Bolus cada 1-2' hasta máximo de 4 mg, o perfusión continua de 2 mg Naloxona en 100 ml de SSF a 10-40 ml/hora.
- En ausencia de respuesta pensar en asociación con otros tóxicos. Además, la Naloxona puede provocar síndrome de abstinencia en adictos a opiáceos, recomendándose por ello dosis bajas repetibles.

Considerar siempre medidas de soporte vital, Oxigenoterapia y ventilación mecánica si precisa.

Tratamiento sintomático en el resto de complicaciones y observación al menos 24 horas.

KETAMINA

Anestésico general sintetizado en 1962, comercializado en viales para uso parenteral en Medicina y Veterinaria, con potente acción analgésica sin miorelajación. Sus propiedades alucinógenas y estimulantes hacen que el uso ilegal con fines recreativos sea muy frecuente. Se conoce como K, Super-K, Especial-K, Ketalandia, Jet, Super ácido, y Calvin Klein cuando se asocia cocaína. Se adultera con efedrina, cafeína, etc. y se consume iv. IM. sc. e inhalada.

Diagnóstico: eminentemente clínico. Ansiedad, dolor torácico, palpitaciones, alucinaciones, convulsiones, polineuropatía, aumento de presión intracraneal, vértigo y parada cardiorrespiratoria. Es frecuente la taquicardia sinusal y en ocasiones nistagmo y distonía. Es característica la amnesia del episodio, la ausencia de cambios analíticos significativos, y como secuelas, delirio, alucinaciones y otros trastornos psiquiátricos.

Su consumo es detectable en algunos laboratorios de Urgencias. La dosis tóxica se establece en

>2mg/Kg.

Tratamiento: no hay antídoto pero los síntomas se autolimitan en poco tiempo. Benzodiacepinas si precisa por agitación, ansiedad o convulsiones, y Biperideno 5 mg iv lento si distonía.

ÉXTASIS LÍQUIDO (GHB)

El principio activo es el ácido gamma-hidroxi-butírico, GHB, presentado en forma líquida en ampollas 10ml con efecto depresor del SNC, y en ocasiones mezclado o sustituido con alcohol, anfetaminas, cocaína, cannabis, ketamina, alucinógenos o psicofármacos. No debe confundirse con el “éxtasis” (MDMA), derivado anfetamínico.

Utilizado como droga recreativa por su efecto desinhibidor, euforizante e incrementador de sensaciones táctiles. Puede producir intoxicación grave combinado con otros depresores del SNC que potencian su efecto dosis dependiente.

Diagnóstico: eminentemente clínico. La forma más frecuente de presentación es el coma.

Sensación de mareo e inestabilidad que cursa con muy rápida depresión de conciencia, somnolencia, mioclonías, hipotermia, hipotensión, bradicardia, midriasis alterna con miosis en vigilia e hiporreflexia. El coma es de breve duración y cursa con amnesia retrógrada. Excepcionalmente HTA, convulsiones, ataxia, confusión, agitación, delirio, alucinaciones y depresión respiratoria alternando fases de apnea y normoventilación.

El GHB no es detectable como técnica de Urgencia, por lo que debemos incluir esta intoxicación en el diagnóstico diferencial de coma de origen desconocido. La dosis tóxica son 2,5 g, aproximadamente el equivalente a 2 botellines.

Tratamiento: No hay antídoto. La base del tratamiento es sintomática siendo en ocasiones necesaria la protección de vía aérea y ventilación mecánica por tiempo muy limitado por la rápida resolución clínica.

BIBLIOGRAFÍA

- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Informe 2017 Alcohol tabaco y drogas ilegales en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. NIPO: 680-16-001-3.
- Morán I, **Jaume Baldirà J, Marruecos-Sant L, Nogué S**. Toxicología clínica. Grupo Difusión. Madrid. 2011.
- Nogué S. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias. Ed. Morales i Torres. Barcelona, 2010.
- Lorenzo P, Ladero JM, Leza JC, Lizasoain I. Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación. Ed. Médica Panamericana. Madrid 2009.
- Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia (SEMES). Guía de Actuación en intoxicaciones agudas. Generalidades. Ed. Adalia. Madrid. 2008.
- Dueñas A. Intoxicaciones agudas en Medicina de Urgencia y cuidados críticos. Ed. Masson S.A. Barcelona, 1999.